

CONSENTIMIENTO INFORMADO

RESECCIÓN PULMONAR (LOBECTOMÍA / SEGMENTECTOMÍA ANATÓMICA / NEUMONECTOMÍA) por VATS multiportal, VATS uniportal (UVATS) o toracotomía convencional

Apellido y Nombre	[Apellido y Nombre del paciente]		
DNI	[DNI]	Fecha de nacimiento	[_/_/_]
Edad	[Edad]	Sexo	[Sexo]
Domicilio	[Domicilio completo]		
Obra Social	[Obra Social]	N° de afiliado	[N° Afiliado]
Institución / Sanatorio	[Nombre del Sanatorio]	Fecha del acto	[_/_/_]
Médico interviniente	Dr. Pablo Maynard — Cirujano Torácico UBA — M.N. 121828 / M.P. 232938		

Tipo de resección propuesta (marcar):

☐ Lobectomía ☐ Bilobectomía ☐ Segmentectomía anatómica ☐ Neumonectomía

Vía de abordaje propuesta (marcar):

☐ VATS multiportal ☐ VATS uniportal (UVATS) ☐ Toracotomía convencional

En los casos de abordaje mínimamente invasivo, se informa la posibilidad de conversión a toracotomía abierta si las condiciones intraoperatorias así lo requieren (ver Sección 4).

1. DIAGNÓSTICO

Diagnóstico:

[Completar diagnóstico específico del paciente — ej.: nódulo pulmonar sospechoso en LSD / neumotórax espontáneo recidivante / bulla enfisematosa, etc.]

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Se le explica que el procedimiento se realizará bajo anestesia general, con ventilación unipulmonar (aislamiento del pulmón a operar mediante un tubo endotraqueal de doble luz o bloqueador bronquial). A través de uno o varios pequeños orificios (VATS/UVATS) o de una incisión mayor entre las costillas (toracotomía), se accede a la cavidad torácica para reseca el lóbulo, segmento o pulmón afectado, junto con el muestreo o disección de los ganglios linfáticos mediastínicos correspondientes con fines de estadificación. Al finalizar, se deja colocado uno o más tubos de drenaje pleural (avenamiento) que permanecerán varios días para evacuar aire y líquido y favorecer la reexpansión pulmonar.

3. OBJETIVO Y BENEFICIOS ESPERADOS

Si el diagnóstico corresponde a sospecha de patología neoplásica (nódulo/masa pulmonar):

Obtener diagnóstico histológico definitivo, lograr una estadificación precisa de la enfermedad mediante el estudio de los ganglios mediastínicos, y lograr el control local —y potencialmente la curación— de la enfermedad neoplásica según su estadio.

Si el diagnóstico corresponde a patología benigna (ej. neumotórax espontáneo recidivante, bullas enfisematosas):

Resolver el cuadro agudo (colapso pulmonar) y reducir de forma significativa el riesgo de recidiva mediante la resección de las bullas/blebs causales asociada a pleurodesis mecánica y/o química.

4. RIESGOS Y COMPLICACIONES POSIBLES

4.1 Riesgos generales de la anestesia

- Reacciones alérgicas a fármacos anestésicos, con posible compromiso hemodinámico o respiratorio.
- Complicaciones cardiovasculares (arritmias, hipotensión, isquemia miocárdica, infarto agudo de miocardio).
- Complicaciones respiratorias (broncoaspiración, laringoespasma, dificultad para la intubación, lesión dentaria o de partes blandas de la vía aérea).
- Complicaciones neurológicas infrecuentes asociadas al acto anestésico.
- Excepcionalmente, complicaciones graves con riesgo de vida o muerte relacionadas con el acto anestésico.

4.2 Riesgos generales de la cirugía torácica

- Sangrado intraoperatorio y/o postoperatorio, con eventual necesidad de transfusión de hemoderivados.
- Infección de la herida quirúrgica.
- Neumonía y/o atelectasia postoperatoria.
- Fuga aérea prolongada (mayor a 5-7 días) con necesidad de mantener el/los tubo/s de drenaje pleural por más tiempo del habitual.
- Fístula broncopleuraleal.
- Empiema pleural (infección del espacio pleural).
- Arritmias cardíacas postoperatorias, la más frecuente la fibrilación auricular.
- Trombosis venosa profunda y/o tromboembolismo pulmonar.
- Insuficiencia respiratoria postoperatoria, con eventual necesidad de asistencia respiratoria mecánica prolongada y/o traqueostomía.
- Necesidad de reoperación por sangrado, fuga aérea persistente u otra complicación.
- Lesión de estructuras vecinas: nervio frénico, nervio laríngeo recurrente, esófago, grandes vasos, conducto torácico (quilotórax).
- Dolor postoperatorio persistente (síndrome de dolor crónico post-toracotomía o post-VATS).
- Cicatriz y/o alteración estética; parestesias en el trayecto de los puertos o de la incisión.
- Muerte, como riesgo infrecuente pero posible de todo procedimiento quirúrgico mayor bajo anestesia general.

4.3 A — Riesgos específicos y balance riesgo/beneficio si el diagnóstico es sospecha de patología

NEOPLÁSICA (nódulo/masa pulmonar)

- Hallazgo intraoperatorio o en el informe diferido de anatomía patológica de márgenes de resección insuficientes (resección R1), pudiendo requerir ampliación quirúrgica o tratamiento adyuvante.
- Posibilidad de que la extensión real de la enfermedad sea mayor a la estimada por los estudios preoperatorios (upstaging intraoperatorio), lo que puede modificar la extensión de la resección durante el mismo acto quirúrgico (ampliación a lobectomía, bilobectomía o neumonectomía) o determinar la necesidad de tratamientos posteriores.
- Necesidad de biopsia por congelación intraoperatoria, cuyo resultado puede diferir del informe diferido definitivo.
- Posibilidad, infrecuente, de diseminación tumoral local vinculada a la manipulación quirúrgica.
- Necesidad de tratamientos complementarios (quimioterapia, radioterapia y/o inmunoterapia) según la estadificación anatomopatológica definitiva.
- Posibilidad de recurrencia locoregional o a distancia de la enfermedad, independientemente de la correcta realización técnica del procedimiento.

Riesgos de NO realizar el procedimiento: progresión local y/o diseminación a distancia (metástasis) de la enfermedad, pérdida de la ventana de oportunidad terapéutica curativa, disminución de la supervivencia y necesidad eventual de tratamientos oncológicos más agresivos y con menor probabilidad de curación.

4.3 B — Riesgos específicos y balance riesgo/beneficio si la resección es por patología BENIGNA (ej. neumotórax, bullas)

- Persistencia de fuga aérea que requiera prolongar la internación o una reintervención.
- Recidiva del neumotórax a pesar de la cirugía: la pleurodesis quirúrgica reduce el riesgo de recidiva a valores bajos (aproximadamente 1-5% según las series), pero no lo elimina por completo.
- Posible existencia de lesiones (blebs/bullas) no visibles macroscópicamente durante la cirugía, que pueden originar una recidiva.
- Al tratarse de patología no oncológica, el balance riesgo/beneficio debe evaluarse especialmente en pacientes con baja reserva funcional respiratoria.

Riesgos de NO realizar el procedimiento: recidiva del neumotórax con nuevos episodios de dificultad respiratoria, riesgo de neumotórax a tensión (potencialmente mortal), necesidad de tratamientos reiterados con tubo de drenaje pleural y mayor riesgo acumulado con cada recidiva.

5. ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS

Si sospecha neoplásica: biopsia percutánea diagnóstica sola sin resección; radioterapia estereotáxica corporal (SBRT) en pacientes no candidatos a cirugía; tratamiento sistémico exclusivo según estadio; conducta expectante con seguimiento por imágenes (no recomendada ante alta sospecha de malignidad).

Si patología benigna: tratamiento conservador con tubo de drenaje pleural sin cirugía; pleurodesis química a través del tubo de drenaje sin cirugía; observación clínica en episodios de bajo volumen.

6. DECLARACIÓN DEL PACIENTE

Declaro que el Dr. Pablo Maynard y su equipo me han explicado, en lenguaje claro y comprensible, mi diagnóstico, el procedimiento propuesto, sus beneficios esperados, los riesgos y complicaciones posibles —generales y específicos—, las alternativas terapéuticas disponibles y las consecuencias previsibles de no realizar el procedimiento. He tenido la oportunidad de formular todas las preguntas que consideré necesarias y las mismas fueron respondidas de manera satisfactoria. Comprendo que la Medicina no es una ciencia exacta y que no se me ha garantizado un resultado determinado. En consecuencia, presto mi consentimiento libre, voluntario e informado para la realización del procedimiento descrito en el presente documento, incluyendo los procedimientos anestésicos necesarios para su realización.

7. AUTORIZACIONES ADICIONALES

- ☐ Autorizo la ampliación o modificación del procedimiento planificado si, durante el acto operatorio, surgieran hallazgos imprevistos que a criterio del equipo actuante hagan necesario o conveniente dicho cambio para preservar mi salud o mi vida.
- ☐ Autorizo la administración de hemoderivados (transfusión) en caso de ser necesario.
- ☐ Autorizo el envío de las muestras/tejidos obtenidos a estudio anatomopatológico y, de corresponder, a estudios moleculares/genéticos complementarios.
- ☐ Autorizo la toma de fotografías/videos del procedimiento con fines académicos y/o de docencia, resguardando mi identidad (Art. 8º, Ley 26.529). En caso de no autorizar, tildar la opción correspondiente:
- ☐ No autorizo la toma de fotografías/videos con fines académicos.

8. REVOCABILIDAD DEL CONSENTIMIENTO

Entiendo que este consentimiento puede ser revocado por mí en cualquier momento previo a la realización del procedimiento, sin necesidad de expresar causa y sin que ello genere consecuencia negativa alguna sobre mi atención médica posterior (Art. 10, Ley 26.529).

9. FIRMAS

Firma: _____ PACIENTE — Nombre: _____ DNI: _____	
Firma: _____ REPRESENTANTE LEGAL (si corresponde) — Nombre: _____ DNI: _____ Vínculo: _____	
Firma y sello: _____ MÉDICO INTERVINIENTE	Firma: _____ TESTIGO (opcional) — Nombre: _____ DNI: _____